

 SCHINDLER INTENSIVPFLEGE FÜR LEBEN UND WERTSCHÄTZUNG	Notfallstandard Verdacht auf Schlaganfall	Qualitätshandbuch
		Geltungsbereich: Pflegefachkraft

Definition:

In Folge einer intrazerebralen Blutung oder eines thrombotischen Verschlusses kann es im Gehirn zu einer Minderdurchblutung kommen. Je nach Lokalisation der Schädigung sind unterschiedliche Symptome die Folge.

Bedeutungsgleich sind die Begriffe Hirninfarkt, Apoplexie, apoplektischer Insult, zerebrovaskulärer Insult und zerebrale Ischämie.

Ein Frühwarnzeichen für einen nahenden Schlaganfall ist „TIA“ (transitorische ischämische Attacke).

Die Symptome ähneln denen eines Schlaganfalls. Häufig tritt eine Hemiparese (inkomplette Lähmung einer Körperhälfte) sowie eine Monoparese (Lähmung einer einzelnen Extremität) auf. In vielen Fällen erleiden Betroffene flüchtige Sehstörungen, sowie Aphasie (zentrale Sprachstörung) und Apraxie (Störung von Handlungen oder Bewegungsabläufen).

Die Symptome halten wenige Minuten bis 24 Stunden an.

Die nächste Vorstufe wird als PRIND (prologniertes reversibles ischämisches neurologisches Defizit) bezeichnet. Auch hier ähneln die Symptome einem Schlaganfall.

Allerdings dauert die Rückbildung bis zu sieben Tage. Bei einer CT-Untersuchung ist der Hirninfarkt häufig gut sichtbar.

1. Ziel:

- Ein Schlaganfall wird schnell und korrekt erkannt
- Bis zum Eintreffen des Notarztes wird der Bewohner korrekt versorgt
- Der Notarzt und die Klinikärzte erhalten alle, für die Behandlung notwendigen Informationen
- Die Folgen eines Schlaganfalls werden auf ein Minimum reduziert

2. Anwendungsbereich:

Symptome:

- Schwindelgefühle
- Erbrechen
- Gesichtslähmungen
- Sehstörungen
- Sprachstörungen
- Missempfindungen oder Lähmung einer Körperhälfte

3. Durchführung und Zuständigkeiten:

Grundsätze:

- Wenn hinreichende Anzeichen für einen Schlaganfall sprechen, wird immer ein Notarzt gerufen
- Der Notruf erfolgt auch dann, wenn der Bewohner diesen nicht wünscht, etwa weil er die Gefährdung nicht richtig einschätzt
- Eine schriftliche Patientenverfügung wird beachtet, insbesondere bei Reanimation

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2024		1	1	Verw./MA

Zur besseren Lesbarkeit wird die männliche Form der Anrede genutzt. Selbstverständlich sind alle Geschlechter gemeint.

 SCHINDLER INTENSIVPFLEGE FÜR SENIEN UND KRANKHEITEN	Notfallstandard Verdacht auf Schlaganfall	Qualitätshandbuch
		Geltungsbereich: Pflegefachkraft

- Die Mitarbeiter werden regelmäßig in Erste-Hilfe-Schulungen über Symptome und Maßnahmen eines Schlaganfalls geschult

Risikoeinschätzung:

Wir stellen zusammen, welchen Risiken der Bewohner bislang ausgesetzt war. Je mehr Belastungsfaktoren zutreffen, umso wahrscheinlicher ist es, dass bei entsprechenden Symptomen tatsächlich ein Schlaganfall die Ursache ist.

Risikofaktoren sind:

- Hohes Lebensalter
- Arteriosklerose
- Hypertonie
- Stoffwechselerkrankungen, wie Diabetes mellitus
- Adipositas
- Bewegungsmangel oder Bettlebigkeit
- Hyperlipidämie (Erhöhung der Blutfettwerte)
- Rauchen
- Blutgerinnungsstörungen
- Herzerkrankungen (insbesondere Vorhofflimmern und Herzrhythmusstörungen)
- Kurz zurückliegende Infusionen oder Transfusionen
- Mentaler Stress

Symptome bei einem Schlaganfall:

Es wird auf die Symptome bei einem Schlaganfall geachtet. Je mehr der hier gelisteten Krankheitszeichen auftreten, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit für das Vorliegen eines Schlaganfalls.

Physische Symptome:

- Lähmung der willkürlichen Bewegung
- Hemiparese (inkomplette Lähmung einer Körperhälfte)
- Hemiplegie (vollständige Lähmung einer Körperhälfte)
- Typische „Schlaganfall-Haltung“ (sichtbare Veränderungen sind zumeist auf eine Körperseite beschränkt):
 - Eine Schulter und das Becken sind nach hinten gezogen
 - Der Rumpf ist einseitig verkürzt
 - Der Arm ist „nach innen“ gedreht
 - Der Ellenbogen ist in Beugestellung
 - Die Finger sind gebeugt
 - Der Daumen wird nahe am Körper geführt
 - Das Bein ist gestreckt
 - Der Fuß hängt schlaff durch der Innenrand des Fußes ist hochgezogen
- Die Stütz- und Gleichgewichtsreaktionen sind gestört. Der Bewohner kann weder aufrecht stehen noch sitzen
- Bewegungen laufen zur gelähmten Seite hin

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2024		1	2	Verw./MA

Zur besseren Lesbarkeit wird die männliche Form der Anrede genutzt. Selbstverständlich sind alle Geschlechter gemeint.

 SCHINDLER INTENSIVPFLEGE WIR LEBEN WERTSCHÄTZUNG	Notfallstandard Verdacht auf Schlaganfall	Qualitätshandbuch
		Geltungsbereich: Pflegefachkraft

- Das Gesicht wirkt asymmetrisch in Folge einer Gesichtsnervenlähmung
 - Ein Mundwinkel hängt einseitig schlaff herab
 - Die Falte zwischen Nase und Oberlippe ist einseitig verstrichen
 - Ein Augenlid „hängt“
 - Beim Ausatmen wölbt sich eine Wange einseitig (sog. „Tabakblasen“)
- Der Bewohner leidet unter Schluckstörungen bis hin zur Schlucklähmung
- Die Zungenmuskulatur ist gelähmt
- Der Bewohner ist plötzlich stuhl- und urininkontinent
- Augen und Kopf weichen zur gelähmten Körperhälfte ab
- Der Bewohner klagt unvermittelt über extreme, fast betäubende Kopfschmerzen
- Cheyne-Stokes-Atmung (rhythmisch variierende, zu- und abnehmende Atemfrequenz; das Atemzugvolumen sowie Atempausen sind unregelmäßig)
- Biot-Atmung (kräftige Atemzüge von gleicher Tiefe werden durch unvermittelt auftretende Atempausen unterbrochen)
- Akutes Kreislaufversagen (Schock)

Psychische Symptome:

- Verwirrheitszustände
- Bewusstseinsbeeinträchtigung bis hin zur Bewusstlosigkeit
- Depression
- Aggressives Verhalten
- Labilität
- Gedächtnisstörungen
- Angst bis hin zur Panik
- Anosognosie (Unfähigkeit, eine eigene Erkrankung bzw. die vorhandenen Funktionsausfälle zu erkennen)

Neurologische Symptome:

- Das vegetative Nervensystem ist beeinträchtigt. Folgen:
 - Schwitzen
 - Erhöhter Blutdruck
 - Herzrhythmusstörungen
 - Erhöhter Blutzuckerspiegel
 - Speichelfluss aus dem Mundwinkel an der gelähmten Seite
 -
- Schwäche und Missempfindungen, insbesondere im Gesicht und in den Armen
- Aphasie (zentrale Sprachstörung)
- Dysarthrie (Sprechstörungen)
- Räumliche Orientierungsstörungen (Entfernungen und Größenverhältnisse werden falsch eingeschätzt; der Bewohner ist nicht mehr in der Lage, nach Dingen zu greifen.)
- Hemianopsie (Halbseitenblindheit mit Ausfall einer Hälfte des Gesichtsfelds)
- Apraxie (Störung von Handlungen oder Bewegungsabläufen)
- Neglect (halbseitige Vernachlässigung des eigenen Körpers oder Umgebung)

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2024		1	3	Verw./MA

Zur besseren Lesbarkeit wird die männliche Form der Anrede genutzt. Selbstverständlich sind alle Geschlechter gemeint.

 SCHINDLER INTENSIVPFLEGE WIR LEBEN MIT SCHINDLER	Notfallstandard Verdacht auf Schlaganfall	Qualitätshandbuch
		Geltungsbereich: Pflegefachkraft

- Alexie (Unfähigkeit, den Sinn von Gelesenem bei funktionierendem Sehvermögen zu erfassen)
- Akalkulie (Rechenstörung bei intakter Intelligenz)
- Der Bewohner ist nicht in der Lage, Pflegekräfte, Angehörige oder Mitbewohner zu erkennen
- Das Erinnerungsvermögen ist eingeschränkt
- Das Geruchs- und Geschmacksvermögen ist ausgefallen oder stark eingeschränkt
- Auf einer Körperseite ist der Bewohner nicht mehr in der Lage, Berührungen, Wärme-, Kälte- oder Schmerzreize zu fühlen

Durchführung:

- Bei Gefahr von Kontamination mit Blut oder anderen Körperflüssigkeiten oder Körperausscheidungen sind Handschuhe zu tragen
- Wenn der hinreichende Verdacht auf einen Schlaganfall besteht, wird umgehend gehandelt
- Holen von Hilfe von Kollegen über das Diensthandy oder der Rufanlage
- Der Bewohner wird in sein Bett gebracht
- Ein Bewohner bei vollem Bewusstsein wird in die Rückenlage (Oberkörperhochlage) gebracht
- Ein bewusstloser Bewohner wird in eine stabile Seitenlage gebracht. Die Atemwege müssen freigehalten werden.
- Die Zahnprothese wird entfernt
- Es wird der Notarzt informiert (**Rufnummer 0-112**)
- Es wird mit der Rettungsleitstelle vereinbart, dass ein Mitarbeiter des Hauses die Rettungskräfte vom Haupteingang bis zum Zielpunkt begleitet
- Nach Eintreffen des Notarztes nach ärztlicher Anordnung
- Der Bewohner wird nicht allein gelassen. Die Pflegekräfte versuchen ihn zu beruhigen
- Einengende Kleidungsstücke werden geöffnet
- Die Vitaldaten werden ermittelt, insbesondere Blutdruck, Puls, Blutzucker und Körpertemperatur
- Die Krankenhauseinweisung wird gemäß Verfahrensanweisung vorbereitet
- Der chronologische Verlauf der bisher aufgetretenen Symptome wird kurz zusammengefasst
(Bsp.: 07:00 Uhr: Der Bewohner klagt über massive Kopfschmerzen, erbricht spontan;
07:15 Uhr: Bewohner verliert das Gleichgewicht und fällt vom Stuhl usw.)
- Das Medikamentenblatt und Diagnosen werden für den Notarzt bereitgehalten

Nachbereitung:

- Information an die Pflegedienstleitung oder die Einrichtungsleitung. Wenn die Notsituation an einem Wochenende/Feiertag eintritt, wird die Information am kommenden Werktag weitergegeben
- Information an Angehörige/Betreuer
- Information an den Hausarzt
- Information an die Verwaltung

Dokumentation:

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2024		1	4	Verw./MA

Zur besseren Lesbarkeit wird die männliche Form der Anrede genutzt. Selbstverständlich sind alle Geschlechter gemeint.

	Notfallstandard Verdacht auf Schlaganfall	Qualitätshandbuch
		Geltungsbereich: Pflegefachkraft

Der Verlauf der Geschehnisse wird von der Pflegekraft dokumentiert unter:

- Berichtblatt
- Ärztliche Kommunikation
- Vitalwerte
- Pflegeüberleitungsbogen
- alle getroffenen Maßnahmen werden genau dokumentiert

Durchführungsverantwortlichkeit/ Qualifikation:

- alle Pflegekräfte

Prozessverantwortlichkeit:

- Pflegedienstleitung, QMB, stellvertretende PDL, Wohnbereichsleitung

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2024		1	5	Verw./MA

Zur besseren Lesbarkeit wird die männliche Form der Anrede genutzt. Selbstverständlich sind alle Geschlechter gemeint.